# EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
# INTERVENCIÓN – EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Problema / Necesidad de Salud** | El reto general que enfrenta la CCSS en el ámbito de la Prestación de los Servicios de Salud (PSS) es alcanzar una prestación adecuada, oportuna y eficaz que permita hacer frente a la mayor cantidad de necesidades de salud de la población, sujeta tanto a un conjunto limitado de recursos como a una creciente demanda por los servicios de salud.<br><br>En ese contexto, es apremiante hacer un uso óptimo de los recursos, para lo cual se requieren estrategias apropiadas y susceptibles de ser evaluadas, con el fin de realimentar la gestión.<br><br>Es importante resaltar que la Atención Primaria de Salud (APS) es la estrategia más aceptada por la mayoría de los sistemas de Salud desde su proclama en Alma Ata, 1978, hasta su reafirmación en Astana, 2018. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no es la excepción, ya que cuenta con una organización de la Prestación de Servicios de Salud en tres niveles, en donde destaca la creación de Áreas de Salud conformadas en el Primer Nivel de Atención (PNA) por Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y sus respectivos Equipos de Apoyo, a fin de implementar el enfoque centrado en las personas y atender las necesidades de salud. (WHO, 1978; WHO, 2019; CCSS, 2019b).<br><br>Cabe destacar que el PNA es el pilar de la APS, ya que permite una adecuada accesibilidad de la población a los servicios, con una atención oportuna y eficaz, por eso, APS también ha sido reconocida internacionalmente como una excelente estrategia para lograr una mayor eficiencia en el Segundo y Tercer Nivel de Atención. |
| **Evidencia** | La Prestación de Servicios de Salud con base en un PNA robusto y efectivo, ofrece la posibilidad de alcanzar mejoras sustantivas en accesibilidad, calidad, oportunidad de los servicios, así como en la eficacia de la atención y la reducción de costos. Abundante literatura internacional sustenta lo anterior:<br>• Los sistemas de salud orientados a la atención primaria están asociados con menores costos de atención, mayor satisfacción de la población con sus servicios de salud, mejores niveles de salud y un menor uso de medicación (Starfield, 1994, p.1131).<br>• La APS es más asequible y tiene una repercusión mayor en la prevención, la promoción de la salud y la prestación de servicios donde las personas viven (OPS, 2019, párr.2).<br>• Las actividades de prevención primaria y promoción de la salud ofrecen la posibilidad de prevenir hasta el 70% de la carga de morbilidad (OMS, 2008, p.8).<br>• En el PNA se resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes; además de permitir una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz (Vignolo et al., 2011, p.12). |
| **Consideraciones de** | **Barreras:** |

# EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
# INTERVENCIÓN – EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Implementación** | • Crecimiento de las necesidades de salud<br>Ocasionado por: sociedad más informada que demanda con mayor frecuencia servicios curativos y preventivos; aumento en la esperanza de vida y de mayores de 60 años que requieren más servicios y de mayor costo; cambio del perfil epidemiológico con predominio de enfermedades crónicas que requieren tratamientos largos y costosos, y; aparición de resistencia a tratamientos usuales y de bajo costo. (MINSA, 2003, p. 5).<br>• Problemas en la Prestación de Servicios de Salud<br>Tales como: brechas de acceso, aceptabilidad, efectividad, eficiencia y continuidad de la atención de la población; atención episódica, centrada en la enfermedad y en hospitales, con énfasis en la atención de cuadros agudos o las complicaciones debidas a las condiciones crónicas (que no garantiza ni integralidad ni integración, ni ofrece suficientes acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y participación de la comunidad en actividades de la prestación y autocuidado); prestación orientada a la oferta de servicios, con poca alineación a las necesidades de la población; Heterogeneidad de los establecimientos en, organización, dotación de recursos (EBAIS, Equipos de Apoyo) y servicios prestados; y, carencia de lineamientos técnicos institucionales que delimiten el trabajo en Red. (CCSS, 2019b, pp. 16- 18).<br>**Estrategias:**<br>• De acuerdo con CCSS (2019b, pp. 31- 50) destacan:<br>Énfasis en promoción y prevención; enfoque de atención centrado en las personas; adecuada estructura organizativa y funcional del conjunto de profesionales que ejecutan la APS así como la ejecución de trabajo multidisciplinario; y organización de servicios de salud basada en componentes, niveles de atención y operación en Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS).<br>• Además, no deben dejarse de lado estrategias tales como:<br>La vigilancia de la ejecución eficiente del gasto y estimular la eficiencia en la implementación de las acciones en APS. |
| **Normativa Técnica** | General:<br>• CCSS (2020). Reglamento del Seguro de Salud<br>• CCSS. (2021). Política Presupuestaria<br>Por disciplinas:<br>*Medicina*<br>• CCSS. (2018c). Manual para la gestión de los servicios de Consulta Externa<br>*Enfermería*<br>• CCSS. (2023). Manual Gestión Enfermería Atención primaria<br>*Farmacia* |

**EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD
EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN**

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| | • CCSS. (2015). Política Institucional de Atención Farmacéutica<br>• CCSS. (2017a). Instructivo Cuadro No. 31B Informe Estadístico Atención Farmacéutica<br><br>*Nutrición*<br>• CCSS. (2018a). Manual de Instrucciones de Trabajo. Nutrición, Áreas de Salud, CCSS<br>• CCSS. (2017b). Organización Funcional de la disciplina de Nutrición en los tres niveles de atención<br><br>*Trabajo social*<br>• CCSS. (2019a). Manual de Gestión de Servicios de Trabajo Social<br><br>*Psicología*<br>• CCSS. (2014). Manual de procedimientos de la consulta externa en psicología de la CCSS.<br><br>*Odontología*<br>• CCSS. (2018b). Manual de Procedimiento. Plan local de desarrollo de los servicios de odontología de primer y segundo nivel de atención. |
| **Costo / Efectividad** | • De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)<br><br>Las intervenciones esenciales de alto impacto para enfermedades no transmisibles (ENTS) pueden realizarse mediante un enfoque de atención primaria de salud fortaleciendo la detección oportuna y el tratamiento temprano. La evidencia muestra que tales intervenciones son excelentes inversiones económicas, ya que si se proporciona atención temprana a los pacientes, se puede reducir la necesidad por tratamientos más costosos. (WHO, 2020, p.1).<br><br>• Con la implementación de las Áreas de Salud, según Rosero- Bixby (2004), se redujo significativamente la mortalidad de los niños en 8% y la de los adultos en 2%. El efecto fue de 14% en la mortalidad de adultos debida a enfermedades transmisibles o desencadenadas por procesos infecciosos, nulo en la debida a causas sociales y similar al total (2%) en la mortalidad debida a enfermedades crónicas; además, la brecha en la equidad del acceso a los servicios de salud en el primer nivel de atención se redujo significativamente. El porcentaje de personas sin acceso equitativo a los servicios de salud del primer nivel de atención se redujo en 15% entre 1994 y 2000 en las áreas que adoptaron la reforma en 1995–1996, mientras que en las áreas que no habían adoptado la reforma en 2000, la reducción fue solo de 3%.<br><br>• De acuerdo con VanderZanden (2021), la reforma de APS de Costa Rica ha mejorado la calidad de la atención médica y los resultados de salud al tiempo que gasta menos en atención médica que el promedio mundial (7,6% del PIB versus el promedio mundial del 10,0% en 2016) y por el gasto per cápita ($889) versus el promedio mundial de $1,026 en 2016). En cuanto a resultados, existe evidencia de mejoras en |

**EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**
**INTERVENCIÓN – EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN**

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| | acceso y calidad, por ejemplo, las muertes por enfermedades transmisibles disminuyeron de 65 por 100.000 personas en 1990 a 4,2 por 100.000 en 2010, y la mortalidad materna e infantil ha disminuido desde 1995; en la primera década de implementación hubo una reducción del 8 por ciento en la mortalidad infantil y una reducción del 2 por ciento en la mortalidad adulta general.<br>• Hodes & Kovacevic (2021) señalan, que entre las ventajas que se pueden atribuir a las redes de atención primaria, se encuentran: economías de escala, el desarrollo de costo- efectividad, los servicios comunitarios, compartir las mejores prácticas y los sistemas de tecnologías de información, así como una mejora en la calidad de la atención. |
| **Objetivo (s) de la Evaluación** | Retroalimentar desde una perspectiva económica el proceso de conducción de la Prestación de Servicios de Salud, tanto en el Nivel Institucional como en las Direcciones de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (DRIPSS) y en el Nivel Local; buscando inducir a las unidades prestadoras a alcanzar un rendimiento óptimo de los recursos, así como a identificar insuficiencias en recursos que interfieren con su rendimiento y/o con las metas de cobertura de atención de las necesidades de salud prioritarias de la población. |
| **Pregunta (s) de Evaluación** | ¿Cuál es el comportamiento en el tiempo de la eficiencia en las Áreas de Salud?<br>¿Cuál es la variabilidad de la eficiencia en las Áreas de Salud y cuáles variables la podrían explicar?<br>¿Cuál es la relación entre la productividad y disponibilidad de recursos en las Áreas de Salud? |
| **Indicadores asociados a la intervención** | 11-02-2.0 Comportamiento del Gasto en Sueldos para Cargos Fijos por Consulta<br>11-02-3.0 Comportamiento del Gasto en Tiempos Extraordinarios |
| **Anexos** | No hay |
| **Referencias Bibliográficas** | Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2014). Manual de procedimientos de la consulta externa en psicología de la CCSS. Código MT.GM. DDSS.ARSDT-PSI.001 Versión 02. Gerencia Médica. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento. Coordinación Nacional de Psicología.<br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2015). Política Institucional de Atención Farmacéutica. Versión 02. Gerencia Médica, Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, Área de Regulación y Sistematización, Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos<br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2017a). Instructivo Cuadro No. 31B Informe Estadístico Atención Farmacéutica. Gerencia Médica, |

**EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD
EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN**

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| | Dirección de Proyección de Servicios de Salud, Área de Estadística en Salud; Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, Área de Regulación de Diagnóstico y Tratamiento, Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2017b). Organización Funcional de la disciplina de Nutrición en los tres niveles de atención. Gerencia Médica. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento. Coordinación Nacional de Nutrición.<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018a). Manual de Instrucciones de Trabajo. Nutrición, Áreas de Salud, CCSS. M.IT.GM.DDSS.ARSDT.N.181018. Versión 02. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento, Coordinación Nacional de Nutrición.<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018b). Manual de Procedimiento. Plan local de desarrollo de los servicios de odontología de primer y segundo nivel de atención. Código MT. GM. DDSS. ARSDT-CNO- 240418 Versión 01<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018c). Manual para la gestión de los servicios de Consulta Externa.<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2019a). Manual de Gestión de Servicios de Trabajo Social. Código M.GM. DDSS- ARSDT-TS.211119. Versión 01. Gerencia Médica. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2019b). Marco Conceptual y Estratégico para el Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud. Versión 3.1<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2020). Reglamento Del Seguro De Salud. Junta Directiva.<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Política Presupuestaria 2022-2023 del Seguro De Salud, Régimen De Invalidez, Vejez Y Muerte Y Régimen No Contributivos De Pensiones.<br><br>Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Manual Gestión Enfermería Atención primaria.<br><br>Herrera, J.(2002). Objetivos de la atención farmacéutica. Recuperado de: Objetivos de la atención farmacéutica (elsevier.es)<br><br>Hodes, S., Kovacevic, L. (2021). Primary care networks: Where are we? Where is the evidence base? What might the future bring? BMJ. 375: n2925, 2021 11 26<br><br>Lauzán, O. (2020). Costos en salud: un asunto polémico. Revista Cubana de |

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| | Salud Pública. 2020;46(2):e2054.<br><br>Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA]. (2003). Gasto y financiamiento de la salud en Costa Rica: Situación actual, tendencias y retos.<br><br>Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2008) Informe sobre la salud en el mundo 2008. La atención primaria de salud Más necesaria que nunca.<br><br>Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2019). La Atención Primaria De Salud Hacia La Salud Universal. Consejo Directivo. 71ª Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. CD57/INF/5. 19 de julio del 2019<br><br>Puig- Junoy, Jaume. Eficiencia en la atención primaria de salud: una revisión crítica de las medidas de frontera. Rev. Esp. Salud Pública 200& 74: 483-495. N.” 5-6 - Septiembre-Diciembre 2000.<br><br>Rosero-Bixby, L. (2004). Assessing the impact of health sector reform in Costa Rica through a quasi-experimental study. Revista Panamericana de Salud Pública 15(2):94-103<br><br>Schram, A. (2009). Análisis de costo-efectividad y costo-beneficio Programa de Detección Temprana de Cáncer Gástrico en Costa Rica. Población y Salud en Mesoamérica, vol. 6, núm. 2, enero-junio, 2009. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. E-ISSN: 1659-0201, revista@ccp.ucr.ac.cr<br><br>Starfield, B. (1994). Is primary care essential? The Lancet, Volume 344, Issue 8930,1994, Pages 1129-1133, ISSN 0140-6736, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(94)90634-3. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673694906343)<br><br>VanderZanden, A., et al. (2021). What Does Community-Oriented Primary Health Care Look Like? Lessons from Costa Rica (Commonwealth Fund, Mar. 2021). https://doi.org/10.26099/ehbv-g283<br><br>Vignolo, V., Vacarezza, M., Álvarez, C. y Sosa, A. (2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Arch Med Interna 2011; XXXIII (1):11-14<br><br>World Health Organization [WHO]. (1978). Declaration of Alma- Ata. International Conference on Primary Health Care, Alma- Ata, USSR, 6-12 September 1978<br><br>World Health Organization [WHO]. (2019). Declaration of Astana. Global Conference on Primary Health Care. From Alma-Ata towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals. Astana, Kazakhstan, 25 and 26 October 2018<br><br>World Health Organization [WHO]. (2020). WHO Package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for primary health care. Geneva. ISBN 978-92-4-000922-6. |